

Basisuntersuchung HWS

1. Inspektion & Palpation
2. Flexion (aktiv/passiv) – Bewegungsumfang, Qualität, Schmerz
Extension (inkl. Mundöffnung) – Bewegungserweiterung durch Mundöffnung
3. Retraktion / Protraktion – aktive und passive Durchführung
4. Lateralflexion rechts/links – mit Schulterelelevation zur Schmerzprovokation
5. Rotation rechts/links – aktive und passive Bewegungsgrenze
6. Wiederholte Bewegungstests in alle Richtungen, falls nötig –
Zentralisationsphänomene

Weiterführende Untersuchung

1. 3D-Zusatztests: Flexion/Extension + Rotation + Lateralflexion – Hypo-/Hypermobilität, Schmerzprovokation
2. Lateralflexion lokal
3. PA-Mobilisation zentral/lateral – Segmentbeweglichkeit
4. Lateralgleiten – Beweglichkeit C1–C7
5. Neurologischer Status: Motorik (C1–Th1), Sensibilität (C5–Th1), Reflexe (Bizeps, Trizeps, Radius-Periost), Babinski, Scapulohumeral-Reflex 1 und 2
6. Neurodynamische Tests – z. B. ULNTT 1-3
7. Spurling's Test (Nervenwurzelproblematik)

Untersuchung Hochzervikal (C0-C3)

1. Side-Bending Stress Test in neutral, extension und flexion (Ligg. Alaria)
2. Sharp Purser Test, Anterior Shear Test (Lig. Transversum)
3. Protraktion, Retraktion (mit Augenbewegungen), Protraktion/Retraktion mit
Latflex+Rot gleichsinnig/gegensinnig
4. Lokale Lateralflexion (C2-C3)
5. Axiale Rotation rechts/links + Extension/Flexion (C0-C2)
6. Lateralflexion rechts/links + Rotation Gleich-/gegensinnig
7. Zervikaler axialer Rotationstest (Flexion + Rotation, C1-C2)
8. Provokation/Mobilität: PA zentral (C1-C3)

Behandlungstechniken HWS

- Wiederholte Bewegungen (Flexion, Extension, Rotation, Pro-/Retraktion, Lateralflexion) – symptommodifizierend
- Myofasziale Techniken (Kompression, Dehnung, Faszientrennung, OA-Release) –
Schmerzlinderung, Detonisierung
- Biomechanische Mobilisationen mit Bewegung (MMB) – z. B. Extension/Flexion mit
Druck/Traktion

- Arthrogene Mobilisationen (global und lokal) – Traktion, Gleittechniken, 3D-Gleiten
- Traktionstechniken aus Schonhaltungen oder zur Korrektur – statisch/dynamisch
- Lateralgleiten – C1–C7 zur Mobilisation
- PA-Mobilisationen – zentral/lateral, zur Segmentöffnung
- Neuralmobilisation – ULNT-Techniken (z. B. N. medianus), Gleit-/Spanntechniken

Therapie Hochzervikal

1. Myofaszial